



I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Windy Audia Conita, S.Kep., Ns
2	Kejadian	Labu darah AB tidak terpakai Unit Kerja yang terlibat
3	Unit Kerja yang terlibat	IRNA 2B
4	Tanggal Kejadian	13/02/2026 - 15/02/2026
5	Nama Pasien	UMIASIH
6	No. RM	138701

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

TANGGAL	JAM	KRONOLOGI	STAFF YANG TERLIBAT
14/02/2026	13.45	Perawat pagi (Ivanus) operan dengan perawat siang (Windy) pasien atas nama Ny. Umiasih/ 75 Th/ BPJS 3 dengan DPJP dr. Ardhany datang ke IGD dengan keluhan sesak. Advice dr. Ardhany O2 Plug Diit dm rp rg, minum 600 cc/24 jam Semi fowler Iv furosemide 10 mg/jam Iv ranitidin 2x1 Iv santagesic 3x1 Iv ceftriaxon 2x1 Nebule ventasal tiap 8 jam Po ketoacid 1x1 Po sucralfat 3xCl Po alprazolam 0.5 malam Po isdn 3x5 mg Prc 1 labu premed dipenhidramin Lab se R.biasa	Ivanus Windy
	16.30	Perawat Windy asistensi dr. Ardhany dan mendapat advice tambahan • Cek BGA • KIE Terminal • KIE HD bila memenuhi syarat • KIE ventilator (menunggu konfirmasi DPJP) • Cek DL post PRC sekaligus CR	Windy
	17.00	Perawat windy langsung melakukan advice tambahan dr. Ardhany, KIE keluarga terkait kondisi pasien dan kemungkinan untuk HD bila memenuhi syarat dan klinis, kemungkinan intubasi	Windy



		atau perburukan kondisi lainnya. Perawat Windy menginput cek BGA di erm dan meminta bantuan perawat Mila untuk mendampingi mengambil sampel BGA pasien lalu kemudian segera menurunkan ke laboratorium.	
	17.41	Perawat Windy melakukan TTV sore pasien Umasih Keluhan : sesak TD : 130/80 mmHg N : 80x/menit S : 36,7 C RR : 24x/mnt SpO2: 98% on NRBM 15 lpm	Windy
	17.45	Perawat Windy konfirmasi ke pihak laborat via telfon ruangan bahwa akses transfusi, tensi dan suhu pasien aman untuk dilakukan transfusi sehingga meminta labu darah dikirim keruangan untuk segera dilakukan transfusi. Beberapa menit kemudian laborat telfon ruangan mengonfirmasi kondisi pasien apakah sesak karena baru saja di cekkan BGA dan nilai kritis sehingga menyarankan untuk konfirmasi ke DPJP apakah transfusi darah tetap dilakukan mengingat klinis pasien sesak karena takut jika PRC tetap masuk dengan kondisi sesak tersebut dipertengahan transfusi sesak semakin memberat. Perawat Windy konfirmasi DPJP by WA terkait saran laborat beserta mengirimkan hasil BGA dan nilai kritis pasien.	Windy
	19.45	Perawat Windy mengonfirmasi ulang dr. Ardhanay terkait pertimbangan intubasi dan pindah ICU by WA, balasan dr. Ardhanay terkait labu darah dan nilai kritis BGA pasien 'Drip Nabic 50meq dalam NS 500cc habis 12jam PRC disimpan' Perawat Windy mengonfirmasi ke pihak laborat untuk tunda pengiriman labu darah keruangan karena dari DPJP tunda terlebih dahulu menunggu KU pasien baik. Pihak laborat menginformasikan jika labu darah pasien golda AB sehingga jika tidak jadi masuk tidak dapat diretur	Windy



	20.30	Perawat siang (Windy) operan dengan perawat malam (Umar) pasien atas nama Ny. Umiasih/ 75Th/ BPJS 3/ DPJP : dr. Ard hany/ DX: DM + CKD stage 4 + Anemia R/ Jalan furopump 10mg/jam UT/ Shift PC 600cc/ 24jam R/ Cek GD tiap sebelum makan R/ Nebul ventasal/8jam R/ PRC 1 labu premed diphen (-) ditunda karena klinis px sesak (atas konfirmasi DPJP) R/ KIE terminal (+) KIE HD bila memenuhi syarat (+) KIE ventilator + (keluarga sudah terKIE DPJP dan perawat) (+) R/ Cek BGA (+) >> balasan, drip nabic 50meq dalam NS 500cc habis 12jam (-) R/ Cek DL post PRC + CR (-)	Windy
	22.00	Perawat Umar menjalankan advice untuk drip Nabic 50meq dalam NS 500cc habis 12 jam	Umar
15/02/2026	05.51	Perawat umar melakukan cek GD sebelum makan dan TTV pasien Ny. Umiasih TD: 155/78 mmHg Nadi: 88 x/menit Spo2:99.00 lpm Suhu:36 C RR:20 x/menit	Umar
	06.43	Perawat malam (Umar) operan dengan perawat pagi (Windy) Ny. Umiasih/ 75Th/ BPJS 3/ DPJP : dr. Ard hany/ DX: DM + CKD stage 4 + Anemia R/ Jalan furopump 10mg/jam UT/ Shift PC 600cc/ 24jam R/ Cek GD tiap sebelum makan (ada novorapid 3x4IU) R/ Nebul ventasal/8jam R/ PRC 1 labu premed diphen (-) ditunda karena klinis px sesak (atas konfirmasi DPJP) R/ Drip nabic 50meq dalam NS 500cc habis 12jam (+) terpasang sejak pukul 22.00	Umar



		R/ konsul ICU menunggu nabic dan konfirmasi DPJP (-) R/ Cek DL post PRC + CR (-)	
	07.45	Perawat Windy konfirmasi ke DPJP jika Nabic 50meq sudah habis apakah perlu dilakukan BGA ulang, balasan dr. Ardhan by WA: 'Lanjutkan. Cek skrinning HD dan Cr'	Windy
	08.30	Perawat Windy bergegas melaksanakan advice menjalankan nabic 50meq dalam NS 500 habis 12jam (jalan jam 08.30) dan mengambil sampling skrinning HD dan CR serta melakukan KIE kekeluarga terkait tindakan tersebut	Windy
	10.30	Perawat Windy melakukan cek GD sebelum makan dan TTV pasien Ny. Umiasih TD: 104/53mmHG N: 80x/mnt S: 36,2 C RR: 27x/mnt SpO2: 98% on NRBM 15 lpm GD sebelum makan :	Windy
	10.40	Perawat Windy melaporkan hasil skrinning HD dan CR terbaru pasien by WA ke dr. Ardhan, balasan: 'KIE HD dengan segala risiko' Perawat Windy melakukan KIE kekeluarga Ny. Umiasih terkait kemungkinan dilakukan HD dengan risiko kondisi pasien saat ini hingga risiko kemungkinan terburuk. Keluarga meminta diberikan waktu untuk berunding terkait tindakan tersebut.	Windy
	11.00	Perawat windy menanyakan kelanjutan tindakan apakah keluarga berkenan jika dilakukan HD dengan segala risiko tersebut, keluarga menolak karena mengingat kondisi pasien yang terlihat tidak memungkinkan namun ingin diberi waktu lebih untuk berunding lebih lanjut dan menunggu keluarga yang lain terlebih dahulu Perawat Windy melakukan konfirmasi ke DPJP by WA jika memungkinkan keluarga tidak berkenan	Windy



		untuk dilakukan HD dikarenakan kondisi pasien namun meminta waktu lebih untuk berunding terlebih dahulu dengan anggota keluarga lainnya	
	13.45	Perawat pagi (Windy) operan dengan perawat siang (Ilma) Ny. Umiasih/ 75Th/ BPJS 3/ DPJP : dr. Ard hany/ DX: DM + CKD stage 4 + Anemia R/ Jalan furopump 10mg/jam UT/ Shift PC 600cc/ 24jam R/ Cek GD tiap sebelum makan (ada novorapid 3x4IU) R/ Nebul ventasal/8jam R/ PRC 1 labu premed diphen (-) ditunda karena sampai KU pasien memungkinkan FU DPJP golda pasien AB dan tidak dapat diretur jika labu darah tidak jadi di transfusi - R/ Drip nabic 50meq dalam NS 500cc habis 12jam (+) jalan sudah siklus ke 2 terpasang sejak pukul 08.30 siklus I = 22.00 siklus II = 08.30 FU apakah perlu BGA ulang - R/ Cek DL post PRC (?) fu apakah perlu dikarenakan tunda transfusi R/ Cek skrinning HD dan Cr ulang (+) >>>> rencana HD menunggu keluarga berunding	Windy
	15.00	Perawat Ilma Observasi TTV ke Ny. Umiasih, didapatkan hasil Keluhan : penurunan kesadaran dan sesak TD : 115/78 mmHg N : 89x/mnt S : 36,4c RR : 28x/mnt Spo2 : 98% NRBM 15 lpm Perawat Ilma mendapatkan kondisi pasien belum stabil untuk dimasukkan PRC, dan lapor ke dr. Ard hany, Sp.Pd. Kgh untuk kondisi terbaru pasien	Ilma
	15.48	dr.Ard hany.sp.PD.KGH visite didampingi perawat lzzaty, melihat kondisi pasien yg menurun dr.Ard hany mengadvice kan untuk menambahkan inj dopamine 5mcg/kgbb/menit dan BGA ulang	lzzaty



		dan sudah di cekkan bga, dan sudah konsul ulang ke dr.ardhany,sp.kgh, jawaban dr.ardhany,sp.kgh Konsul anastesi dgn ards, Pertimbangan ventilator, setelah di konsulakan icu by wa, kemudian icu by telfon jwabannya ventilator penuh,	
	21.45	Operan dengan perawat izaty pasien umiasih rencana pindah icu dengan dgn ards, Pertimbangan ventilator, di icu ventilator masih penuh setelah operan keliling ke pasien, pasien penurunan kesadaran, kemudian perawat husnita telfon dokter jaga igd ada code blue di 2b atas nama umiasih, dr. nurdiana mengadvisekan RJP 30 siklus + inj epineprin 2 amp , setelah di lakukan RJP 30 siklus + inj epineprin 2 amp, pasien di ekg dan hasilnya asystole, kemudian dokter nurdiana KIE keluarga pasien MD 21.44	Izzaty
	21.50	Perawat Husnita melakukan konfirmasi ke laboratorium bahwasannya pasien yg akan dilakukan tranfusi darah meninggal dunia dan dari petugas laboratorium mengatakan bahwa darah tidak bisa dikembalikan/di retur dikarenakan golongan darah pasien AB+.	Husnita

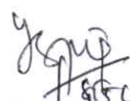
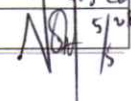
III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

- | | |
|---|----|
| 1. Penurunan kondisi pasien yg menyebabkan labu darah tidak dapat tersalurkan ke pasien | 2. |
|---|----|

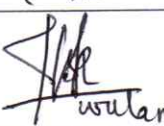
IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

- | |
|--|
| 1. Labu darah tidak terpakai sampai dengan expired |
| 2. Biaya tambahan yg membengkak |

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

*Kepala Ruang	1. Setiap pemberian tranfusi darah wajib dilakukan pengecekan kondisi pasien, sebelum, saat dan sesudah tranfusi darah dilakukan 2. Tidak membebaskan ke unit jika memang diakibatkan oleh kondisi pasien, karena bukan termasuk keteledoran staf 3. Unit laboratorium menyediakan penyimpanan untuk golongan darah AB+ sehingga tidak sampai darah expired Ketika ada pembatalan penggunaan darah	
*Kabid Keperawatan		
*Kabid Penunjang Medik	1. Perawat Kabid ruang labu darah diganti oleh unit, koordinasi dengan DPSP.	
*SDM RS	Proses sesuai dengan ketentuan.	



*Kabid Penunjang	- cek kondisi px dgn benar sebelum memberikan fraktur - Gel AB tidak mudah didapat, sehingga hrs diorderkan - 96.95 PMI, maka wajib proses dgn benar - penggantian oleh petugas yg bersangkutan	 Fandi
*Kabid Umum	- Proses sesuai ketentuan - Pembayaran / penggantian oleh pihak ybs	 Wulan

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada

Pembuat Kronologi


()


(Windy Andia Comba)

Catatan Direktur : _____